

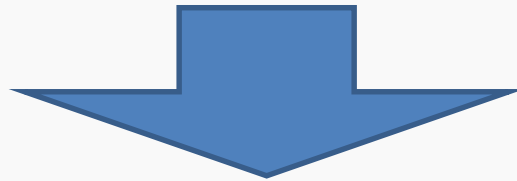
Организационные решения по перераспределению функций между медицинским и немедицинским персоналом, а также автоматизации работы сотрудников медицинских организаций.

Начальник отдела
по амбулаторно-поликлинической службе
Минздрава РБ

Танцыкужина Альбина Гумаровна

Проблематика

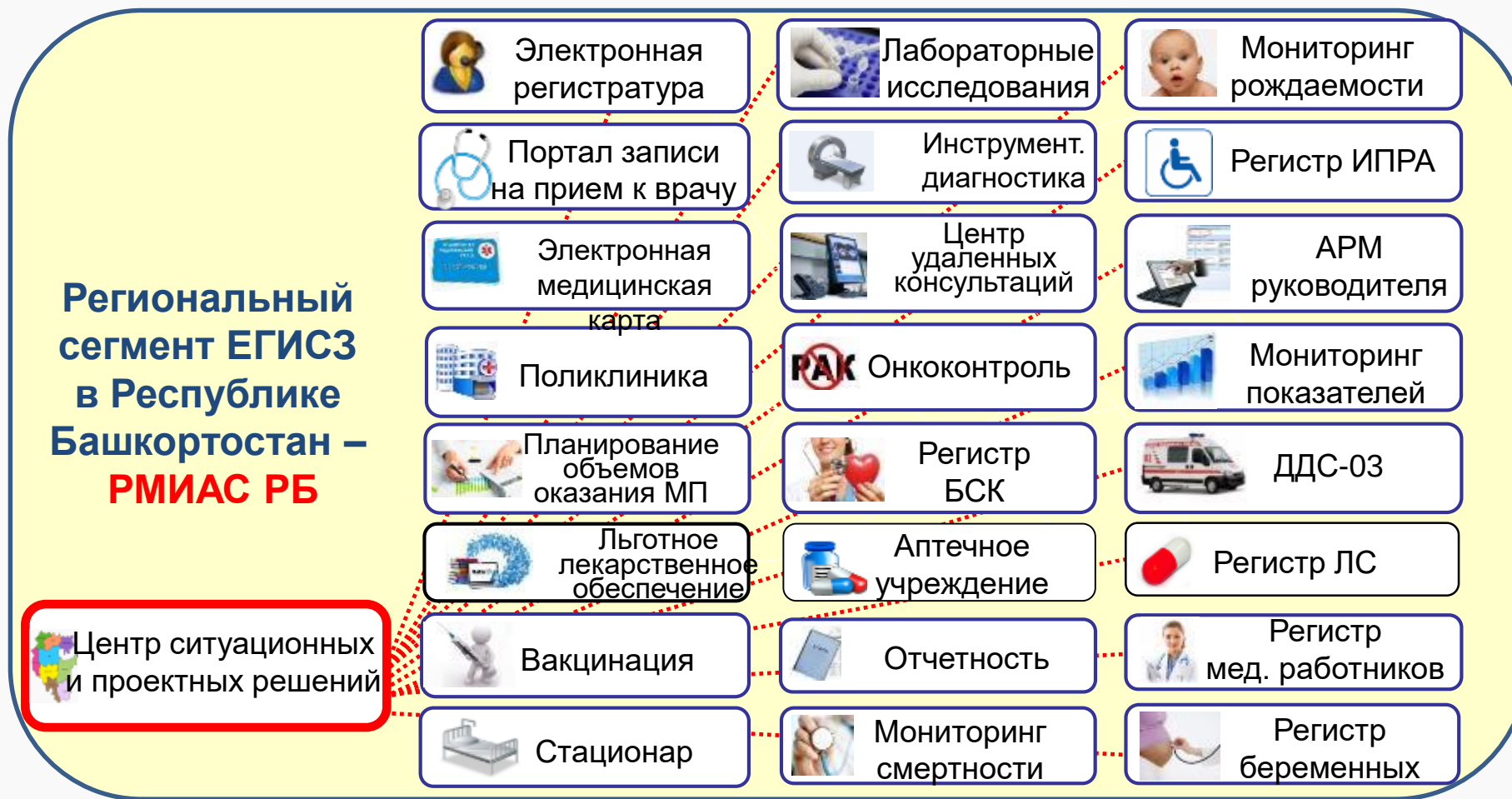
- Большой объем отчётности требуемой от врача в текущих реалиях;
- Незавершённый переход на полный электронный документооборот вынуждает врачей дублировать записи в бумажной форме (исключительно ради проверок страховых компаний);
- До 60% пациентов не нуждались в осмотре врача и подлежали первичной маршрутизации.
- Недостаток кадров. На 2022 год обеспеченность кадрами терапевтической службы составляла:
 - терапевтами участковыми – 3,40, при нормативе 5,9 для городского населения и 7,7 для сельского населения на 10000 взрослых жителей.
 - врачами общей практики – 0,12
 - участковыми медицинскими сёстрами – 3,5, при нормальном соотношении 1:1 к участковому врачу терапевту



Высокая загруженность врачей и в наибольшей мере участковых врачей-терапевтов

РМИАС РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Наполняемость и реализация программных модулей РМИАС РБ на текущий момент позволяет передавать большую часть статистически-аналитических задач немедицинскому персоналу ввиду отсутствия необходимости ручного формирования медицинским персоналом выборок пациентов по категориям, нозологиям и прочим критериям.



Функции переданные немедицинскому персоналу

Отчет - Форма №30 раздел №3-2100

Форма №30 раздел №3-2100
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. Таблица (2100).

МО: ГБУЗ РБ Поликлиника № 43 г.Уфа

Филиал:

Подразделение: ГБУЗ РБ ПОЛИКЛИНИКА №43 г. Уфа, филиал по

Группа отделений: Филиал по ул. М.Рыльского 10

Отделение: 1. Терапевтическое отделение № 2

Врач: Абдрахманова Фирдаус Ахтямовна

Вид обращения: [Все]

Вид оплаты: [Все]

Дата начала: 01.01.2023

Дата окончания: 20.02.2023

Включать посещения по ДД: Да

Включать посещения по профосмотрам: Да

Включать посещения по ДДС: Да

Включать посещения по осмотру несовершеннолетних: Да

Только ГУЗы: Нет

- Информирование пациентов о врачебном приеме, в том числе с целью прохождения диспансерного наблюдения;
- Сопровождение пациентов на диагностические и лечебные процедуры;
- Регулировка потока пациентов на врачебном приеме;
- Предоставление информации по вопросам приёма населения непосредственно или с использованием технических средств, в том числе электронных;
- Получение результатов лабораторных и других исследований пациентов и внесение сведений в медицинскую документацию;
- Ведение паспорта врачебного (терапевтического) участка;
- Ведение персонального учета, информационной (компьютерной) базы данных состояния здоровья обслуживаемого населения.
- Ведение карантинных карт пациентов с ОРВИ и Covid-19

Журналы

Наименование

Список карт профилактических прививок

Журнал План прививок

Журнал назначенных прививок

Журнал Учет профилактических прививок

Журнал Планирование туберкулинодиагностики

Журнал Манту-назначено

Журнал Манту-реакция

Журнал медотводов

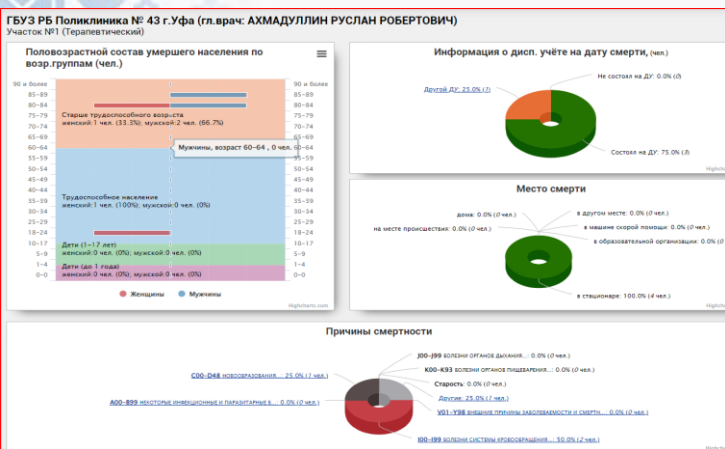
3. Доп фильтр

Период планирования: 01.02.2023 - 28.02.2023

Назначение:

Исполнить Обновить Печать

Дата наз...	Фамилия	Имя	Отчество	Дата ро
21.09.2021	Абдрахманов	Айдар	Венерович	23.10.19
11.01.2022	Абдуллин	Даниль	Идиатович	25.07.19
14.09.2020	АБДУЛМАН	АНВАР	МАЗТАРОВИЧ	07.09.19



Регистр льготников: Список

Категории льготы

Региональные льготы

- D59.3 Гемолитико-уремический синдром
- D59.5 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафави-Микели)
- D61.9 Апластическая анемия неуточненная
- D68.2 Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стьюарта-Прауэ)
- D69.3 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса)
- D84.1 Дефект в системе комплемента
- E22.8 Преждевременная половая зрелость центрального происхождения
- E70.0, E70.1 Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия, д
- E70.2 Тирозинемия
- E71.0 Болезнь "кленового сиропа"
- E71.1 Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью (изовалериановая
- E71.3 Нарушения обмена жирных кислот
- E72.1 Гомоцистинурия
- E72.3 Глютарикацидурия
- E74.2 Галактоземия
- E75.2 Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика
- E76.0 Мукополисахаридоз, тип I
- E76.1 Мукополисахаридоз, тип II
- E76.2 Мукополисахаридоз, тип VI
- E80.2 Острая перемежающаяся (печеночная) порфирия
- E83.0 Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)
- E78.0 Наследственный остеохондр

Маршрутизация пациентов в медицинской организации

Администратор

Основной функцией является разделение потоков входящих пациентов:

- 1) на неотложную помощь
- 2) пациентов пришедших для процедур, не нуждающихся в осмотре врача (выписки льготных рецептов, санаторно-курортных справок и. т.д.)
- 3) для прохождения ДВН, УДВН, ПМО в отделение профилактики
- 4) Обращение без записи с целью консультации

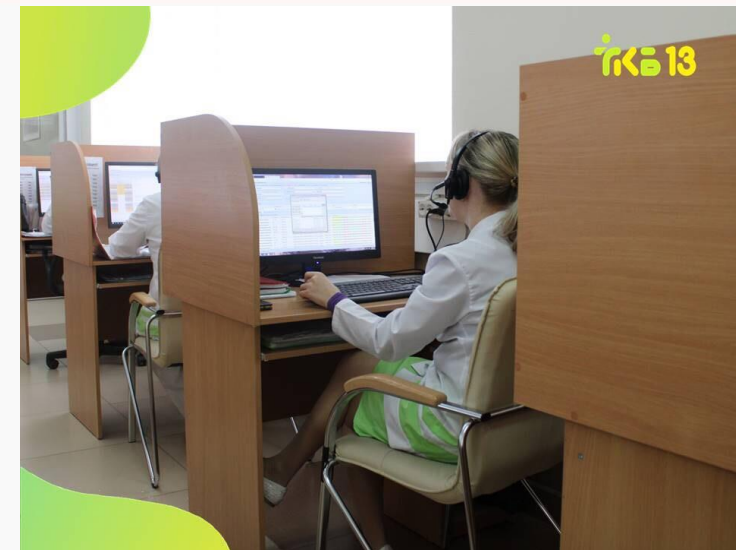


Call-центр

Функция оператора

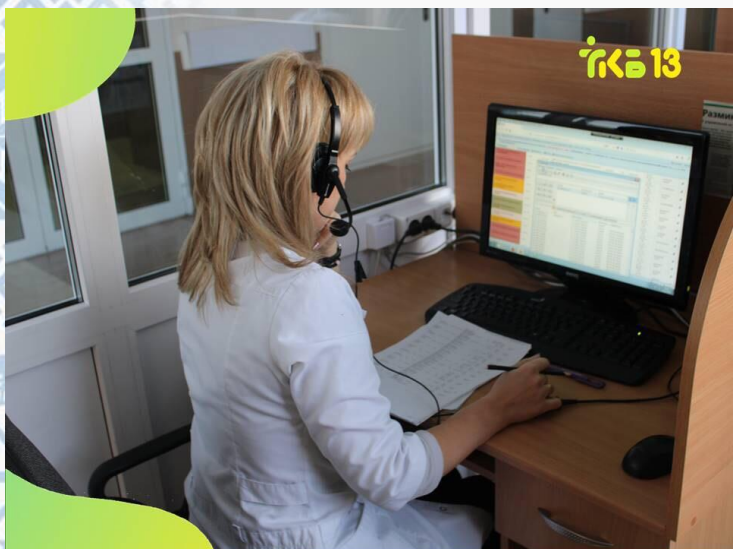
Входящие звонки

- устанавливает цель обращения пациента;
- проводит идентификацию пациента при его обращении;
- осуществляет маршрутизацию пациента на момент исполнения запроса пациента с учётом причины его обращения;
- осуществляет запись на приём к врачу;
- при отсутствии свободных слотов для записи вносит данные пациента в «Лист ожидания»;



Исходящие звонки

- проводит обзвон пациентов (при отсутствии роботизированных сервисов обзвона) с целью подтверждения явки в дату и время планируемого оказания медицинской помощи;
- проводит информирование пациентов по телефону (при отсутствии роботизированных сервисов обзвона) об отмене записи на приём к врачу по инициативе медицинской организации с последующей перезаписью пациента;
- при появлении свободных слотов на запись к врачу информирует об этом пациента из листа ожидания и при его согласии записывает его на приём к врачу;
- проактивно формирует поток по профилактической работе;



Медицинский персонал → немедицинский персонал

Мероприятие	Результат
Маршрутизация пациентов «От двери» или «С первого звонка» Администратор, Телефоны горячих линий,	• ~68% обращений могут быть закрыты без приёма участкового терапевта, т.к. их причиной является следующее: • Выписка регулярных рецептов в течении 3 месяцев после осмотра врача • Получение справок, направлений • Справочное консультирование • Запись к специалистам
Работа Call-центров. Внедрение автообзвона.	• Дистанционный контроль состояния пациентов. Высвобождает до 1 часа работы медицинского персонала. (меняется в зависимости от эпидобстановки). • Сокращение количества неявившихся на приём пациентов. • Повышение доступности путём освобождения слотов за счёт пациентов отказавшихся при обзвоне от имеющейся предварительной записи. По участковой сети до 15-20%. Специализированный приём 10-15%. • Приглашение для прохождения диспансеризации и диспансерного контроля. Освобождает до 9 часов рабочего времени в месяц на 1 участок.
Ведение паспорта участка, отчетной документации. Формирование различных списков и заполнение регистров пациентов	Освобождает до 8 часов рабочего времени в месяц на 1 участок.

Функции переданные среднему медицинскому персоналу

- Проведение фельдшерами I этапа диспансеризации (в т.ч. углубленной);
- Проведение медицинских осмотров (профилактических, предварительных, периодических);
- Диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями;
- Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий (карантина);
- Оценка эффективности и безопасности применения медикаментозных и не медикаментозных методов лечения.
- Активное посещение маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения;
- Организация и проведение школ здоровья;
- Оформление листков нетрудоспособности;
- Выписка регулярных рецептов в течении 3 месяцев после осмотра врача;
- Оформление справок, выписок, санаторно-курортных карт;
- Контроль проведения профилактических мероприятий;
- Направление пациента на лабораторные и инструментальные обследования

Диспансеризация взрослого населения – 1 этап: Поиск

Год: 2022

Нажмите на заголовок чтобы свернуть/развернуть панель фильтров

Тип поиска человека: 1. По текущему состоянию ☐ Учитывать архивные данные

1. Пациент 2. Пациент (дет.) 3. Прикрепление 4. Адрес 5. Листок 6. Диспансеризация 1 этап 7. Пользователь

МО прикрепления: ГБУЗ РБ Поликлиника №43 г.Уфа

Тип прикрепления: 1. Основной

Тип участка:

Основной участок:

ФАП Участок:

Актуальность прикр-я: 1. Актуальные прикрепления

Дата прикрепления: Диапазон дат прикрепления:

Дата открепления: Диапазон дат открепления:

Условн. прикр.: ДМС прикрепления:

Изначально Пропустить Удалить Обновить Печать

Фамилия	Имя	Отчество	Д/р	МО проведения	Обслужен моб.
Абдуллина	Татьяна	Татьяна	17.04.1952	Нет	
Абдуллина	Татьяна	Сергеевна	02.03.1977	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	10.01.1984	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	06.06.1949	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	12.12.1976	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	10.06.1979	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	26.07.1993	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	07.05.1967	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	27.02.1993	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	29.01.1971	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	18.06.1940	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	07.11.1946	ГБУЗ РБ Полик...	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	23.12.1955	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	01.08.1959	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	10.08.1951	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	18.11.1967	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	04.08.1966	ГБУЗ РБ Полик...	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	08.07.1980	ГБУЗ РБ Полик...	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	23.10.1974	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	01.03.1977	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	10.06.1963	Нет	
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	18.05.1967	Нет	



Контрольные карты диспансерного наблюдения: Список

ГБУЗ РБ Поликлиника №43 г.Уфа

Диспансеризация 1 этап

Оформление карты диспансерного наблюдения: Только актуальные

Поставивший врач:

Ответственный врач:

Учитывать историю ответственных врачей: ☐

Добавить Изменить Пропустить Копировать Обновить Печать Заменить ответственного врача

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Диагноз	Вид	Смет	Дата след. визит
Абдуллина	Татьяна	Татьяна	15.09.1951	О80.0	20.08.2019		18.05.2023
Абдуллина	Татьяна	Сергеевна	15.09.1946	О20	11.06.2022		18.05.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	02.02.1982	О40.0	07.12.2017		25.02.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	03.08.1958	О20	04.04.2022		23.02.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	07.04.1954	О25.0	21.04.2021		23.02.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	25.01.1943	О20	30.03.2022		11.06.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	28.04.1976	О80.0	07.02.2019		22.04.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	21.08.1960	О80.0	02.11.2020		13.06.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	21.05.1960	О25.0	09.10.2019		25.05.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	14.06.1963	О80.0	27.05.2020		09.03.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	07.01.1953	О20	23.10.2019		22.04.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	28.04.1968	О80.0	18.11.2017		25.03.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	12.07.1964	О25.0	18.12.2019		23.02.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	04.07.1962	О40.0	30.03.2022		23.02.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	10.11.1988	О40.0	17.04.2017		25.02.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	15.11.1969	О80.0	18.02.2021		27.05.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	11.08.1987	О80.0	22.02.2016		22.04.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	07.05.1951	О40.0	09.01.2018		22.04.2023
Абдуллина	Светлана	Сергеевна	12.02.1981	О40.0	18.02.2016		25.02.2023

Врач → Медсестра

Мероприятие	Результат
Организация Доврачебного кабинета, Сестринского поста,	• За счет переноса приемов пациентов по выписке рецептов в кабинет среднего медицинского персонала высвобождается 5-10% времени врачей в день. • Уменьшение до 30-40% временных затрат на выписку справок, выдачу направлений на анализы и затем результатов анализов. • Предварительный сбор анамнеза и физикальных данных. Высвобождение от 1 до 4 минут на каждом приеме (до 10% времени приема пациентов). • За счет высвободившегося времени увеличение

Функции врача амбулаторно-поликлинического приема на текущий момент

- Диагностика заболеваний;
- Наблюдение пациентов на дому;
- Работа в составе врачебной комиссии;
- Организация медицинской реабилитации;
- Направление на медико-социальную экспертизу;
- Назначение мероприятий по уходу за пациентом;
- Разработка программ оздоровительных мероприятий.
- Проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
- Решение о направлении пациента на консультацию врача-специалиста;
- Назначение лекарственных препаратов, медикаментозного лечения и лечебного питания;



Функции среднего медперсонала на текущий момент



- Прием пациентов для решения вопроса о срочности направления к врачу;
- Выполнение медицинских манипуляций по назначению лечащего врача;
- Оформление медицинской документации;
- Обучение пациента (его законных представителей) и лиц, осуществляющих уход, приемам ухода и самоухода, консультирование по вопросам ухода и самоухода;
- Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения;
- Осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении;
- Проведение иммунизации населения.



Ожидаемые результаты перераспределения функций

Для пациента	Для персонала	Для организации ПМСП
✓ Увеличение доступности медицинской помощи ✓ Удобная логистика получения медицинской помощи, а также административных услуг ✓ Повышение удовлетворенности медицинской помощью	✓ Снижение непрофильной нагрузки на медицинских работников за счёт передачи отдельных функций немедицинскому персоналу ✓ Высвобождение времени врача для непосредственного общения с пациентом ✓ Минимизация риска профессионального выгорания	✓ Выстраивание процессов с применением пациентоориентированных подходов, несущих пользу здоровью пациента ✓ Рост показателей качества и эффективности проведения профилактических мероприятий населению



Благодарю за внимание!